

5 - 02- Conduite à tenir devant une adénopathie cervicale - Pr. DAROUASSI

C'est le même, j'ai enseigné l'anatomie du cours et j'enseigne également en même temps. C'est dans le même chemin, c'est ce qu'on appelle l'enseignement intégré, d'accord ? Intégré, c'est-à-dire c'est le même enseignant qui enseigne aussi bien l'anatomie que la pathologie. Alors rappel anatomique, la région numéro 1, c'est quoi ? La région numéro 1, c'est quoi ? Oui, d'accord.

[illegible]

Oui. Le terrain de football, très bien. Par exemple, est-ce qu'il est excellent, oui.

Est-ce qu'il est tabagique, oui. Est-ce qu'il est alcoolique, quoi d'autre? Alors, il va dire quelque chose, oui. La douleur, le cantage tuberculeux.

Il faut se poser la question sur l'origine du patient. Ainsi, chercher une notion d'irradiation dans l'enfance. Il faut chercher ce qu'il y a amigressement, ce qu'il y a péricrânien, la fièvre, ce qu'il y a des signes respiratoires comme la toux, les ronflements dysphoriques.

Donc, on commence par l'identité du patient. Ensuite, on va chercher le motif de consultation. Donc, ça fait après les antécédents, après les antécédents.

Les antécédents familiaux, un cas similaire dans la famille. On va chercher la notion de contact avec les gens. On va chercher la notion de contact avec les gens.

chercher les antécédents toxiques comme tabac, alcool, chercher la présence d'un tubercule, chercher les antécédents de chirurgie, l'évolution, l'amortisseur, l'amortisseur, oui, et chercher une altération de l'état général. Je pense que ce n'est pas la peine d'assister au cours, vous avez déjà tout dit. Alors, identité, on en a parlé, alcool, tabac, personne n'a parlé du comportement à risque.

Le comportement à risque, ça peut être la HIV, ça peut être la syphilis, antécédents médicaux ou chirurgicaux, date d'apparition, mode évolutif, signes associés au RL, on n'a pas parlé des autologies, les autologies on en a parlé pour le cas clinique, d'accord, et les signes entre

guillemets de compression, ce sont des signes qui montrent la tumeur d'aryngie ou d'aryngie, la dysphagie, la dysphonie et la dyspnée. Et tout à l'heure, votre ami parlait du prurit, d'essayer nocturne, de l'amigrissement, c'est très bien, excellent. Alors, on a parlé de l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on fait à l'examen clinique ? Oui, à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on fait ? Très bien, oui.

On cherche des signes inflammatoires, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? C'est l'inspection, bien sûr, il y a la palpation et également l'auscultation. L'auscultation, si on a une tumeur d'origine, enfin une tumeur battante, une tumeur vasculaire, on peut s'aider de l'auscultation.

Moi, j'avoue personnellement que je n'ai pas de stéthoscope depuis longtemps, mais on s'aide beaucoup de l'inspection et la palpation. L'inspection palpation, il va chercher quoi ? Ça, c'est connu, l'inspection palpation, qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, comment ? Très bien, la rougeur, l'inflammation, la taille peut-être, la mobilité, ce qui est mobile à quoi ? À la déglutition, mais aussi à la protrusion de la langue. Pourquoi la protrusion de la langue ? Parce qu'une tumeur qui est mobile à la protrusion de la langue, ça veut dire qu'il a une relation avec la langue, y compris l'oculoïde.

L'oculoïde qui est l'insertion de la plupart des muscles intrinsèques de la langue, ce qui fait que quelle est la tumeur qui peut être en relation avec l'oculoïde et avec la langue ? Très bien, bravo. Tu donnes tes gains. Voilà, très bien, le KTT.

Et quelle est la masse qui est mobile à la déglutition ? C'est les nodules thyroïdiens. Pourquoi ils sont mobiles à la déglutition ? Parce que la glande thyroïde est accolée à l'axe laryngotracheal. L'axe laryngotracheal remonte à la déglutition.

Pourquoi il remonte à la déglutition ? Voilà, pour l'équipe piglotte, couvrir la déglutition laryngée et empêche les aliments de passer dans les voies aériennes. Alors, inspection palpation, auscultation ciblant est très important pour les gens vraiment... Je sais, les cours, enfin, l'après-midi, c'est très difficile. J'étais... je suis passé par là.

C'est très difficile de suivre un cours l'après-midi. Alors, il faut un schéma qui est très important, c'est qu'il soit adapté, un schéma qui est adapté, qui va montrer un peu la localisation et continuer par l'examen général. Qu'est-ce qu'on va chercher, par exemple, à l'examen général ? Fièvre, oui, fièvre, tension artérielle, on ne sait pas, les constantes, température, oui, dans le cadre d'une tuberculose, très bien.

Un patient qui présente un cancer, il peut présenter peut-être des métastases osseuses, osseuses particulières. Moi, je me rappelais d'un patient qui avait un cancer de larynx, et chaque fois, à chaque visite, il me disait « Docteur, j'ai mal à la cheville ». Et arrête de nous déranger tout le temps. Et un jour, on a fait une radio comme ça, en fait, c'était pas moi.

Je demandais aux résidents « J'ai mal », et personne ne faisait attention. Et moi, je suis arrivé en

héros un jour pour la visite. « Qu'est-ce que tu as, monsieur ? » « Oui, j'ai mal ». « Allez, descendez-le faire une radio », d'accord ? Et puis, on a découvert une métastase osseuse, d'accord ? Alors, il ne faut jamais prendre à la légère les plaintes du patient, surtout dans le contexte d'un cancer.

Je vais peut-être dire... Voilà. Alors, en ce qui concerne notre examen, on a fait l'inspection palpation. En tant qu'ORL, qu'est-ce que je vais faire aussi ? Voilà, l'examen nasofibroscopique, pourquoi ? Le cas Bohm, oui, la larynx, oui, le pharynx en général, rhinopharynx, oropharynx et hypopharynx, larynx, cavité buccale.

Dans le sens de quoi ? Qu'est ce qu'on cherche ? On cherche d'abord. Une infection et on cherche aussi la tumeur, d'accord ? Par exemple, vous avez tous eu des, je ne sais pas, des comédiens ou bien des boutons cutanés et vous remarquez par la suite que vous avez l'apparition d'une petite adénopathie. Non.

Ce qu'il dit là. Est ce que vous avez ? Comment ? Le cancer, c'est pas un cancer, c'est une tumeur bénigne. C'est un catété.

C'est quoi ? Le kyste du tractus pteriogloss. C'est une tumeur, c'est une malformation. C'est une tumeur d'origine congénitale.

En fait, c'est un résidu de la migration de la glande. La glande thyroïde, la glande thyroïde, enfin la partie médiane de la glande thyroïde qui va maigrir à partir de la base de la langue vers la loge thyroïdienne. Il peut laisser des reliquats qui donneront ce qu'on appelle un kyste thyroïdose.

Alors, en ce qui me concerne, moi, en tant qu'ORL, je fais un examen ORL systématique et complet, notamment la nasophibroscopie qui va montrer, qui va en fait chercher soit une infection, soit une tumeur maniaque. D'accord ? Alors, l'infection, ça peut être quoi ? C'est une usine. Quelles sont les infections qui donnent souvent des adénopathies cervicales dans votre pratique quotidienne ou bien dans votre vie ? Angine.

Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils viennent et ils vous disent voilà les angines. Alors, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent les adénopathies. Oui.

Quoi d'autre ? Les rhinopharyngites, surtout chez les enfants. Rhinopharyngite, quoi d'autre ? Cynusite, tuberculose. Je parle des infections qui peuvent donner des adénopathies réactionnelles.

Comment ? Très bien, d'origine dentaire, les caries dentaires. Excellent. Angine, caries dentaires et des petites lésions cutanées, des petits grattages.

Moi, quand je me gratte un peu le nez, le lendemain, j'ai une petite adénopathie réactionnée. D'accord ? Alors, une adénopathie dans le contexte aigu, généralement, souvent, souvent, c'est d'origine infectieuse. Alors, il faut faire l'examen de toute la tête et du cou également, la peau.

Pourquoi on fait l'examen de la peau, de la tête et du cou? Bon. Un petit peu de suspense. Très bien, très bien.

Le mélanome, c'est quoi la mélanome? C'est une tumeur maligne d'origine, voilà, d'origine cutanée, c'est une tumeur de très, très mauvaise pronostic. On peut avoir une adénopathie, surtout des adénopathies postérieures. Passons un petit mélanome caché dans le cuir chevelu, il peut passer inaperçu.

D'accord? Excellent. Très bien. Moi là, pas de question, pas de oui, non, non, je pense, non, ça n'a aucune raison de, sauf là, quand il sera infection, peut-être une série d'infections d'origine infectieuse, ça peut donner une réaction.

Oui. Réunion allergique. Oui, alors on fait un bilan.

L'examen clinique, on demande un bilan. Qu'est-ce qu'on demande? Voilà. Alors on a parlé des voies aérodigestives supérieures, également la part de patients de la région thyroïdienne, pourquoi? Parce que ça peut être un tumeur, un adulte thyroïdien, un tumeur qui peut donner des métastases ganglionnaires, l'autoscopie pourquoi? Comment? Oui, excellent, très bien.

Ça peut être une autre étude, ou bien même un cancer de l'oreille. Par exemple, chez les enfants, à vous souhaiter. Ça peut être un cancer de... Alors, autoscopie, ça peut être un cancer.

Moi, je me rappelle d'un enfant qui avait un... qui ressemblait à une autite extérieure maligne. En fait, on a fait une biopsie et ça a été un rhabdomyosarcom. Ah oui, qu'est-ce qu'on demande comme bilan? Là? NFS.

Network, c'est? Normes, animations, formules sanguines, oui, quoi d'autre? Echographie cervicale, ou bien... ou bien parfois un scanner. Parfois, on peut demander carrément un scanner, en fonction du contexte. Mais le plus souvent, l'échographie, c'est l'examen qu'on demande en premier.

C'est un examen qui est capital, qui a beaucoup d'avantages. Il est accessible, il n'est pas cher, il n'est pas irradiant, d'accord? Mais quel est l'inconvénient de l'échographie? Voilà, c'est l'opérateur dépendabilité qui peut gêner parfois l'échographie. Qu'est-ce qu'on demande, Crote? D'autres? Ah oui, très bien.

VSRP, oui. Oui, radiotubes du thorax, ou bien un scanner thoracique. Pourquoi on demande une radiotube du thorax? Ça peut montrer une tuberculose en faveur de la tuberculose, mais quoi d'autre? Voilà, des hémopathies médicinales dans le contexte de l'enfant.

Ou bien des métastases osseuses, ou bien des métastases pulmonaires, d'accord? Métastases pulmonaires dans le cadre d'un cancer. Ou bien une image en faveur de tuberculose, une cavité ou une miliaire, par exemple, tuberculose. Ou bien on peut avoir des images de métastases

osseuses costales, par exemple, d'accord? La radiote thoracique, elle apporte beaucoup d'informations.

Souvent, elle est normale, mais quand elle apporte quelque chose, elle est très contributive, d'accord? Alors, oui. Et qu'est-ce qu'on demande d'autre? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Oui, chez tout le monde. Sur le GVH, en fonction du contexte.

Et bien sûr, sur le GVH, il faut demander l'autorisation du patient. Parce que c'est un examen qui risque de changer la vie du patient, qui va le transformer en quelqu'un, en personne lenta ou en personne séropositive. Ce qui fait qu'il faut demander l'autorisation du patient.

Pourquoi tu as fait cet examen? Il peut gagner, d'accord? Oui, on a oublié un peu l'idée à la tuberculine. C'est un examen que je ne demande plus, sincèrement. Ça n'apporte rien, ça ne donne aucun... Positif, qu'est-ce que ça veut dire? Négatif, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Négatif, peut-être, je vois le seul intérêt, c'est dans le cadre d'une sarcoïdose.

D'accord? Avec l'adénopathie, avec un granulome giganto-cellulaire. Dans la sarcoïdose, avec une idée négative. C'est très en faveur de la sarcoïdose.

Ça permet d'éliminer assez bien, enfin, la tuberculose. À part ça, je ne vois pas l'intérêt, sincèrement. Oui, alors, on a d'autres bilans qu'on demande en fonction... Dites-moi ce que vous pensez, sans triche.

D'accord? Oui? Dites-moi. Comment? L'adénopathie. Mais c'est pas en premier.

Très bien, excellent. Dans quel but? Très bien, c'est un but bactériologique et également, ça peut être également cytologique. Dans le cadre d'une analyse cytologique par les anapathes, par les histopathologistes.

Très bien. Cytoponction, oui. Très bien.

Excellent. Ça y est? Alors, pour la trache, on dirait qu'on avait toujours... Je ne sais pas comment on va décrire ça, mais c'est quelque chose qui vient en fait, comme une sorte de guide à une certaine vitesse, Et, il y a un plan. Un plan d'étude, d'un plan d'étude de... La trache est une sorte d'examen d'une trache, une plan d'étude d'une alimentation, pour qui il est d'avoir sa famille.

On peut demander la procalcitonine parce que ça peut être en faveur d'une réaction bactérienne. Ça c'est fini, on va continuer. Alors, autre examen selon l'orientation, sérologie.

Plusieurs sérologies, HIV, Epstein-Barr virus, toxoplasmose, rébioles, maladie des griffes du chat. De toute façon, ce ne sont pas des sérologies qu'on va demander systématiquement. D'accord? Si un enfant, par exemple, un chat à la maison vient qui aime un peu toucher au chat et qui risque d'être guérifié, on peut demander la sérologie de maladie des griffes du chat.

Quel est le genre qui est responsable? Oui. Même que toi. Regarde, regarde.

Maladie des griffes du chat. Regarde. Reposez 5 minutes.

D'accord? On peut continuer? Tout le monde est là? Qui n'est pas là? Excusez-moi. Qui est là? Qui est le juge? C'est bon? Alors, on continue. Alors, on a parlé des autres examens selon l'orientation.

On a HIV, Epstein-Barr virus, toxoplasmose, rébioles, maladie des griffes du chat, imagerie par TDM ou IRM en fonction du contexte. On peut demander, par exemple, dans le cadre d'un cancer, une TDM ou bien une IRM, par exemple, dans les tumeurs nasosunisiennes. Dans les tumeurs nasosunisiennes, on demande un scanner et une IRM.

Les deux. Le scanner peut montrer l'os, alors que l'IRM, il va montrer plutôt les tissus. D'accord? L'angio-IRM ou bien l'artérographie dans le cadre d'une suspicion de tumeur vasculaire.

Moi, je me rappelle très bien d'un enfant que j'allais opérer. C'était un adulte jeune. En fait, moi, ce n'était pas mon patient, c'était le patient d'un autre confrère qui était absent pour raison de service.

Et j'allais l'opérer. Je palpe. Enfin, il est étiqueté adénopathie cérébrique, à l'allégographie.

À la part du patient, qu'est-ce que je constate? Voilà, une tumeur qui est battante. Tumeur qui est battante. Voilà, le patient, il allait être opéré le lendemain.

Battante, tumeur battante. Voilà, je l'amène voir un radiologue. On fait une onco-dopulaire qui trouve une tumeur vasculaire.

Avec les deux carotidexales internes qui sont écartées et la carotidexale qui est juste sous la peau. C'est un patient qui risquait d'avoir de sérieux problèmes juste à l'incision. Lui, il avait de sérieux problèmes et moi aussi, j'allais avoir de sérieux problèmes.

Alors, moralité, toujours bien examiner votre patient. Il y a certains caractères qui ne trompent pas. Le caractère battant, d'accord, c'est très important.

Également, la mobilité dans le sens vertical et horizontal. Les tumeurs vasculaires sont mobiles dans le sens horizontal, mais pas dans le sens vertical. Pourquoi? Voilà, ils sont le leader du vaisseau.

Le vaisseau, il est mobile dans ce sens, mais il ne va pas bouger dans le sens vertical. Très bien. C'est la fonction lombaire dans le cadre de l'héloropathie.

Également, en cas de suspicion d'un autotiridien, TSH ou bien casse-tônie. La fonction allégue fine. Qui a dit la fonction allégue fine? Ah, c'est toi.

C'est toi qui a dit la fonction alléguée fine. Dans la science, il y a des bactériologiques, mais également il y a des scientologiques. Et je n'ai rien dit, la pan-endoscopie.

C'est quoi pan? C'est total. Pan-endoscopie, endoscopie des branches, endoscopie de l'œsophage, endoscopie du larynx et du pharynx, à la recherche de quoi? Des tumeurs primitives. Et d'ailleurs, la sphère ORL, les voies aérodigestives supérieures, ils ont un point commun, c'est quoi? Qu'ils sont exposés au même facteur de risque.

Dans le cas du tabac et de l'alcool, ils sont exposés au même risque. Ce qui fait qu'un patient qui a un cancer du larynx risque d'avoir un cancer également du poumon. Parce que le poumon aussi, il a été exposé au même facteur de risque.

Et actuellement, avec le développement des traitements et l'augmentation de la survie des patients qui ont des cancers, on remarque que le patient a parfois le temps de développer un deuxième cancer. Le cancer peut être soit métacran, soit syncran. Syncran, découvert au même moment que la découverte du cancer en question, ou bien métacran, c'est-à-dire qu'il va apparaître par la suite, parce que l'organe a déjà été exposé au tabac, par exemple, ou bien à l'alcool.

Ça, c'est quoi la cervicotomie exploratrice avec adénectomie complète ? Et non pas une simple biopsie. La biopsie ganglionnaire, c'est une biopsie complète. On enlève tout le ganglion.

On n'enlève pas seulement un morceau de tissu. On enlève tout le ganglion. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cervicotomie exploratrice, puisqu'il y a parfois le dernier examen complémentaire et le premier geste thérapeutique.

D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Je suis désolé. Alors, on va parler maintenant des diagnostics étiologiques. Soit il y a une adénopathie inflammatoire aiguë ou chronique.

Et on a deux chapitres dans le cadre des cancers. On a l'adénopathie dans le cadre de l'adénopathie maligne et l'adénopathie métastatique. De quoi ? Des voies aérodigestives supérieures.

Dans ce cas, c'est quoi le type étiologique le plus fréquent ? Voilà, le carcinome épidermoïde. Et on a également les adénocarcinomes sus et sous-diaphragmatiques. Alors, sus-diaphragmatiques, c'est plutôt les adénopathies susclaviculaires droites.

Et sus-diaphragmatiques, c'est les adénopathies susclaviculaires gauches. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? C'est bon ? C'est clair ? Alors, on commence par les adénopathies inflammatoires aiguës. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de ces adénopathies inflammatoires aiguës ? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple ? Oui.

Oui. Alors, il peut être d'origine affectueuse. On peut avoir des antécédents d'angine, de rhinopharyngite.

Après, c'est l'antibiotérapie, avec la thérapie antalgique. Pas d'INS ? Non, pas d'INS. Il aggrave les temps, parce qu'il stoppe l'inflammation.

Du coup, on a une aggravation. Avec les INS. Les INS, surtout avec les gens qui vont chez le pharmacien, à la pharmacie pour faire la consultation de pharmacie.

Et puis, voilà, j'ai mal aux dents. Les INS, qu'est-ce qu'ils font ? Ils masquent la symptomatologie. Et voilà, ils empêchent l'immunité d'agir.

Ce qu'il fait, c'est une aggravation à double coup. D'abord, le patient va s'aggraver, mais ababrouille. Il ne va pas faire attention jusqu'à ce qu'il y ait une complication.

Par exemple, la complication qu'on peut avoir ici, c'est l'adénoflagrement cervical, la collection périlleuse, et qui peut aller jusqu'à la cellulose, jusqu'au sepsis, jusqu'au décès. Et quand j'étais en France, les 4 ou 5 cellules que j'ai vues, c'était des patients qui avaient pris des INS. Alors, moralité, ne prescrivez pas.

Si vous prescrivez un anti-inflammateur, plutôt aller vers le corticoïde. Mais le corticoïde, dans ce cas, il est contre-indiqué. Pourquoi ? Enfin, devant une adénopathie, généralement, il ne faut pas donner de corticoïde.

Pourquoi ? C'est surtout dans le cadre du contexte de l'enfant. Si on suspecte un enfant, la corticothérapie va forcer le résultat. Elle va forcer le résultat histologique et on aura du mal à trouver le diagnostic.

Et on va retarder le diagnostic et aggraver le pronostic du patient. Alors, pas d'INS, pas de corticoïde devant une adénopathie. Optez plutôt pour l'antibiothérapie et le traitement antalgique, simple, paracétamol.

Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des patients qui présentent une douleur, puis une tumefaction qui est ferme au début. Alors, les portes d'entrée, ce qu'on appelle une porte d'entrée, ça peut être dentaire, amygdala, rhinopharyngie chez les enfants et cutanée. Tout ça, on l'a dit tout à l'heure.

Alors, il faut traiter la porte d'entrée. Moi, je vois un patient qui a des caries dentaires et qui a des adénopathies. Le premier réflexe, c'est de demander qu'il aille chez le dentiste.

D'accord ? Je mets ce traitement, mais je demande quand même qu'il faut arrêter le problème. Le problème, c'est la source de l'infection, c'est l'origine dentaire. Et puis, traitement médical qui est basé sur les antibiotiques et les antalgiques.

Pas d'anti-inflammatoire, ni INS, ni stéroïdien. D'accord ? Ni inflammatoire, non, stéroïdien, ni stéroïdien à éviter. Et si jamais on a un abcès, comme a bien dit votre ami tout à l'heure, dans ce

cas, on a un traitement chirurgical, c'est l'incision de l'abcès.

Parce que vous savez tous qu'un abcès, le traitement, c'est l'incision. Il faut évacuer le puits pour permettre la guérison, bien sûr, sous couverture antibiotique. Alors, on va maintenant parler des adénopathies chroniques.

On a trois chapitres. L'adénopathie inflammatoire chronique, l'hémopathie maligne et l'adénopathie métastatique. Alors, la métastase, ça peut être la métastase de quoi? Les exemples qu'on a vus tout à l'heure.

C'est à dire de quoi? Oui, aérodigestif. Quel type, quel organe? Larynx. Par exemple, larynx, qu'est-ce qu'il a comme tableau? Quel est le prototype? Oui, le monsieur qui est en stage dans notre service.

Oui, le prototype d'un patient qui a un tumeur de larynx. Voilà, disponible, bien disponible, mais surtout le prototype. Parce qu'on parle souvent dans notre service, on parle des raisonnements, du raisonnement clinique, mais le raisonnement clinique, le médecin, il va s'aider de prototype.

D'accord? Alors, on a le prototype particulier d'un patient qui a un tumeur de larynx. C'est un patient qui va déjà dès l'entrée en consultation. D'accord? Alors déjà, on a le symptôme.

Voilà, disponible. J'entends le, enfin, je, je sens quoi? La cigarette. Et puis, c'est un patient de 50 ans.

Ce que j'évoque en premier devant cette disponibilité, c'est d'abord le cancer de larynx, mais n'empêche qu'il peut avoir d'autres étiologies. D'accord? Alors, on a l'évocation, on évoque, on a des signes d'orientation. Et puis, il faut aller confirmer le diagnostic.

D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que le cancer? On a parlé du cancer de larynx. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut être? Un patient qui a un tumeur de larynx? Oui. C'est quel âge déjà? Voilà.

Alors, on a les deux piques chez nous au Maroc. C'est soit ça ou ça. Oui.

Vous avez étudié les tumeurs de larynx? Est-ce qu'il y en a-t-il deux? Ah oui. Unilatéral, oui. Autismique.

Ce sont les cinq syndromes. Enfin, les quatre ou bien cinq syndromes. Et puis, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de ménousie.

Ménousie qui avait une pistaxe. Qu'est-ce que ça évoque? Les tumeurs de larynx, c'est ça ou non? Les ménousies, ils ont une exposition particulière aux poussières du bois. D'accord? Ce qui fait qu'avec les poussières, certaines expositions professionnelles sont responsables des

cancers nasocynés.

D'un type particulier de cancers nasocynés. Alors, ménovisie, pistaxe, adénopathie, il faut évoquer un cancer nasocynés. On va dire ça rapidement.

Alors, cancer des voies aérodigestives supérieures, la cinquantaine, éthyloabusive, carcinome du cavon, adolescent, adulte, jeune, qui peut avoir la pistaxe et tout ça. Cancer nasocynés, c'est un ménovisien. Cancer oesophagien, pilmon aérodigestif, ça va dans les pléthores.

Attention, c'est un drapeau rouge devant une adénopathie cisclaviculaire. Ne jamais prendre à la légère une adénopathie cisclaviculaire. C'est presque un cancer jusqu'à preuve du contraire.

Un cancer de la région cis-déphragmatique ou bien cis-déphragmatique. Recherche, alors devant ces tableaux, ces suspicions, rechercher une tumeur primitive pour biopsie. Dans ce cas, on peut faire la biopsie.

Il y a un cavon, on peut faire la biopsie du cavon. Mais une adénopathie, on ne fait pas une biopsie. On ne va pas inciser et aller mordre du tissu.

Il faut inciser et disséquer toute l'adénopathie. Et puis, devant un cancer, toujours, toujours devant un cancer, on a d'abord la confirmation qui est souvent toujours histologique. Et après la confirmation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le bilan d'extension et le bilan pré-thérapeutique.

Le bilan pré-thérapeutique et le bilan d'extension. Et en fonction de ces deux bilans, on a des armes thérapeutiques. En fonction du cancer.

Par exemple, le cancer thérapeutique, quels sont les armes thérapeutiques? On a la chirurgie, l'irathérapie, la chimiothérapie, la radiothérapie, en fonction du contexte. Mais dans les autres cancers, on a les trois armes. On a le cancer, on a la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie.

On fait un bilan pré-thérapeutique et puis on fait une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et on va proposer aux patients les différentes options thérapeutiques et on va avoir le consentement du patient. Les patients qui ont un cancer, aucun patient ne ressemble à l'autre.

Chacun a son plan thérapeutique qui est adapté avec son consentement, ce qu'on dit un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on a bien expliqué, on a éclairé le patient, on lui a bien expliqué les choses et puis il va décider. On a parlé des hémopathies métastatiques et puis les hémopathies malignes.

On a les deux types, l'informe Hodgkinien et l'informe non Hodgkinien, mais également d'autres, par exemple, la leucémie de la faute chronique chez le sujet âgé. L'adhésion en bon état général, ça peut être une maladie de Hodgkin ou bien l'informe non Hodgkinien. Et dans ce cas, le CO est un siège d'élection.

Souvent, ce sont des patients qui se manifestent par dysanthropie, donc en dysanthropie cervicale. Et puis, bien sûr, même avec ça, on fait aussi un bilan d'extension également dans les hémopathies malignes. Et puis, dans les deux cas, on fait une réunion de concertation pluridisciplinaire et il faut obtenir le consentement éclairé du patient.

On va parler maintenant des autres hémopathies inflammatoires, mais aussi aiguës, mais chroniques. Quelle est la cause la plus fréquente ? La tuberculose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la tuberculose, par exemple ? Comment on obtient le diagnostic de la tuberculose ? Devant une adénopathie cervicale pré-pistillissante, très inflammatoire, avec des signes associés, notamment la cire nocturne, l'asthénie, l'amigdalite importante.

Non, c'est juste une orientation vers le diagnostic. Juste une orientation. On peut faire un prélèvement de... Vous avez discuté ? On peut faire un pansement de l'adénopathie pour... D'accord.

Voilà, je m'en déconseille. Ça m'a dans quel sens ? Une recherche du PECA, du bacille de coq, oui. Voilà.

Alors, c'est... C'est un diagnostic... On a fait l'évolution. Enfin, la biopsie, on a fait l'économie et on a laissé le patient. On attendait le résultat pendant 10 ou 15 jours.

En même temps, on faisait également la culture, la recherche du PECA et la culture pendant deux mois. Alors, le diagnostic, il était tardif. On attendait au moins 15 jours avant l'adénopathie ou bien deux mois avant la culture avec l'antibacillogramme, ce qui fait que le traitement était un peu tardif.

Actuellement, on fait... On enlève l'adénopathie, on l'adresse au PCR, on a le diagnostic en quelques heures. D'accord ? On a le diagnostic le jour même et on envoie le patient directement au pneumologue pour commencer. Quel est le traitement déjà de la tuberculose ? C'est un traitement anti-bacillaire, mais également peut-être chirurgical en fonction du contexte.

D'accord ? Oui. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Oui, alors c'est la cause la plus fréquente dans notre contexte.

Le germe, c'est le *Mycobacterium tuberculosis*. Alors, cette adénopathie peut être soit isolée, soit associée à d'autres localisations, notamment la localisation pulmonaire, mais également d'autres localisations. Parfois, aspect fluctuant, comme a dit votre ami tout à l'heure, fluctuant pré-fistulaire qui est très évocateur.

C'est le cas clinique qu'on a vu tout à l'heure. On fait un prélèvement. Le prélèvement, il n'est pas obligé de l'avoir, par exemple, par biopsie.

On peut également faire une ponction, ponction du liquide, par exemple, en cas de pré-

fistulisation. On peut faire une ponction. Si on a suffisamment de liquide, on peut l'adresser pour résultat pour PCR.

Et puis, on fait l'infadenictomie, qui va nous donner un versant histologique. C'est le granulome épithéliogé-quantocellulaire avec nécrose casieuse. D'ailleurs, le granulome épithéliogé-quantocellulaire, c'est la seule chose dont je me rappelle, l'anapathie, personnellement.

Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je sais que l'anapathie, c'est très important à enseigner. Mais moi, en ce qui me concerne, personnellement, c'est la seule chose dont je me rappelle.

Je sais que vous êtes très contents d'étudier l'anapathie. Bactériologie. Alors, on a l'histologie, bactériologie avec PCR et antibiogramme sur milieu de culture spécifique.

C'est un milieu de culture spéciale avec des résultats qui sont très tardifs. Il faut avoir un mois ou bien deux mois si on veut l'antibactérogramme. Le traitement, il est médical par les antibactériaires.

Si échec ou bien maladie pneumologue, on peut faire un curage. Alors, on va parler des mycobactéries atypiques. Les mycobactéries atypiques, qu'est-ce que vous pouvez en dire, les mycobactéries atypiques ? Oui ? Oui ? Vous l'avez dit à un moment, mon agent.

Oui ? Très bien. Surtout, également, c'est chez les enfants, c'est plutôt les jeunes enfants. D'accord ? De toute façon, on va en parler rapidement.

C'est un tableau un peu similaire chez les jeunes enfants. Également, ça se pose les mêmes problèmes de la culture qui prend plusieurs semaines. Il faut traiter comme une tuberculose, puis adapter l'antibiogramme et chirurgie parfois nécessaire.

Ça ressemble beaucoup à la tuberculose, mais c'est surtout chez les jeunes enfants. D'accord ? Alors, maladie de griffe de cheveux, c'est quel genre ? C'est le hensalé. Bartonella hensalé.

D'accord ? Alors, monsieur le hensalé. Bartonella hensalé. Alors, la porte d'entrée, c'est surtout une griffure faciale ou bien au cervical par un choc.

Généralement, ça donne une adénopathie qui est satellite de la zone de la griffe. Puisque l'adénopathie cervicale, c'est soit la tête, soit le cou. D'accord ? Alors, il faut isoler le germe ou bien faire une PCR ou une chirurgie.

De toute façon, ça c'est en fonction... Par exemple, chez l'enfant, quel est le pourcentage d'adénopathie qui reste sans étiologie ? C'est pas l'étiologie, à votre avis, chez les enfants ? J'ai pas le chiffre chez les adultes, mais chez les enfants, parce que j'ai fait une présentation dernièrement. Combien ? Quel est le pourcentage, à votre avis ? 60 %. 60 %. 60 %, c'est faux. C'est 60 %. 60 % d'adénopathie chez les enfants reste sans diagnostic.

Il y a une revue de la littérature récente, mondiale, qui propose devant une adénopathie aiguë de traiter ou bien de surveiller. Je parle bien de l'enfant. L'adulte, j'ai pas le chiffre.

D'accord ? Voilà. Alors, isolement... De toute façon, on va essayer de confirmer le diagnostic et le traitement. C'est un traitement antibiotique.

Alors... Mononucléose infectieuse, c'est la maladie qui est due à un gène. C'est le chimbarvirus qui est transmis par... entre autres par la salive. D'accord ? Oui ? D'accord.

Généralement, ce sont des patients qui viennent avec l'adénopathie qui sont très asthéniques, fatigués. Parfois, ils ont une angine également. D'accord ? Parfois, ils ont une angine.

À la numération, on a une monocytose. Une monocytose à la numération. On peut s'aider par d'autres tests.

Le test de la sérologie MNI. Il n'y a pas de traitement spécifique. C'est une évolution qui est spontanément favorable.

Dans des formes très asthéniantes, où le patient est très fatigué, on peut prescrire des corticoïdes. Corticoïdes, dans ce cas, on a déjà confirmé le diagnostic. On ne peut pas le prescrire sans diagnostic.

Est-ce que c'est clair ? Non. Corticoïdes, parce qu'on a déjà confirmé par la sérologie. Toxoplasmose.

Qu'est-ce que vous connaissez de la toxoplasmose ? Elle est transmise par quoi, déjà ? Le chat. Quel est le danger de la toxoplasmose ? C'est une maladie qui est bénée, surtout la femme enceinte. Dans ce cas, il faut si la femme n'était pas déjà atteinte de toxoplasme, dans ce cas, il faut prescrire un antibiotique, l'aspiramicide.

Oui. Sérologie, toxoplasma gondii, il peut parfois donner un syndrome mononucléosique, régression spontanée en plusieurs mois, aspiramicide chez la femme enceinte. Est-ce que c'est clair ? Tout le monde a-t-il des questions ? Pas d'inquiétude ? Quelqu'un d'autre ? C'est comme si quelqu'un qui voulait acheter une carte lui disait « Je viens chez toi ». Je ne lui ai pas dit ça.

Il dit « Je viens chez toi ». Oui. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, la sarcoïdose. J'ai dit toutes les choses.

C'est quoi la sarcoïdose ? « Je viens chez toi ». Oui. Comment ? Granulomatose. Très bien.

Oui. Oui. Oui.

Mais ça peut donner plusieurs symptômes, plusieurs localisations, parmi lesquelles la cause pulmonaire. D'ailleurs, c'est là. C'est en pneumologie.

D'accord ? Et puis, alors, il est généralement associé à d'autres localisations. Alors, le fait d'avoir

des adénopathies isolées révélatrices, j'ai l'impression qu'il n'est pas connu, sarcoïdose, c'est assez rare. D'accord.

Mais ça arrive. J'ai vu au moins une ou deux patients qui ont eu une sarcoïdose découverte à l'occasion d'adénopathie. Mais j'ai vu pas mal d'adénopathies, parmi lesquelles deux ou trois qui ont une sarcoïdose.

L'histologie également. Granulome, épithélio, gigantocellulaire, avec nécrose gradueuse. Très bien.

Ben, d'ailleurs, au moins, il y en a une qui a failli prendre un peu. C'est ça ? Avec ou sans ? Alors, adénopathie sans nécrose caseuse, ça peut être la sarcoïdose, ça peut être la tuberculose. Avec nécrose caseuse, bien sûr, c'est pathogénomique de la tuberculose.

Et bien sûr, la recherche ne trouve pas, la recherche bactériologique ne trouve pas de BK. Et l'intra-adhéron-réaction, je pense que c'est le seul intérêt, en ce qui me concerne, dans mon expérience, c'est le seul intérêt de l>IDR, c'est ça. Je me rappelle d'un patient qui était envoyé chez nous.

On a trouvé un granulome épithélio, gigantocellulaire, sans nécrose caseuse. Et l'interniste, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous avez demandé la recherche de BK ? En fait, le résident, il avait oublié de demander la recherche bactériologique. Mais, je me suis rappelé qu'il a un IDR qui est négatif.

Je lui ai dit, l>IDR, elle est négative, c'est très probablement une sarcoïdose. Et en fait, ils ont refait les investigations et ils ont trouvé une sarcoïdose. Alors, oui.

Oui. Oui. Oui, oui.

Oui, très bien. Ça augmente les autres infections. Oui.

Il faut, il faut penser systématiquement chez les patients qui ont des habitudes de vagabond sexuel. Voilà, dans un certain type d'adéopathie, C'est un symptôme essentiel de début, mais on peut avoir déjà HIV. C'est des gens qui ont été découverts à l'occasion d'une pathologie cervicale et systématiquement, surtout chez un sujet à risque.

Et le traitement, enfin, c'est la psychologie HIV. La syphilis, elle est rare. Peut-être soit, on ne sait pas.

Enfin, il est en recrudescence avec la VIH. Ça peut être soit la syphilis primaire, soit tertiaire. Primaire, c'est une adélephatie qui s'attélite d'une porte d'entrée.

Dans ce cas, vous imaginez que c'est une porte d'entrée orale, d'accord? Et puis, on a, voilà, c'est un chancre oropharyngé. Alors, c'est une porte d'entrée qui est orale. C'est des habitudes

particulières.

Et puis, on a la syphilis secondaire. Dans ce cas, on a plusieurs adélephaties cervicales. Et bien sûr, les sérologies, vous connaissez BTRL et TPSH.

Alors, oui. Autre, qu'est-ce qu'on peut dire sur autre? Tu l'as aimé chez le chasseur, mais c'est une adélephatie cervicale, un chasseur avec son fusil. Tu l'as aimé, d'accord? Voilà, tu es fort.

On suspecte que tu l'as aimé, d'accord? Un résident, un chasseur avec une adélephatie cervicale. Alors, on suspecte qu'il tue les animaux. Alors, tu l'as aimé.

Je vous fais cadeau de ça. Je vous fais cadeau. Je vous fais cadeau.

Qu'est-ce que ça veut dire, je vous fais cadeau de ça? Alors, quand tu dis à quelqu'un, je vous fais cadeau de ça. Tu dis à quelqu'un, ça? On vous fait grâce. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu n'as pas à l'écouter.

Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Pourquoi est-ce qu'on s'unis? Pour savoir ce qu'on peut mettre dans l'examen. C'est ça le but. Quel est l'autre but dans cet enfilé? Votre but.

Pourquoi tu veux bien comprendre? Pour être quoi? Pour être médecin. Pour être médecin, bon médecin. Tu dois être un bon médecin.

Qu'est-ce que tu veux être? Un bon médecin. Vous connaissez les voitures? Je vous donne toujours l'exemple des voitures. Alors, tu peux être médecin.

Il y a des meilleures soignants qui veulent être médecins. Mais pour l'instant, je ne sais pas si les médecins sont ou non. qu'est-ce que c'est? Quel est ton but d'apprendre ça pour l'examen? J'espère que le message est passé.

Il y a comme c'est différentiel alors c'est un grand diagnostic différentiel. Arabe. Binti.

Très bien. Merci beaucoup. Alors diagnostic différentiel Voilà.

Alors quels sont les diagnostics différentiels? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça peut être un diagnostic différentiel d'une adénopathie? Quand je dis diagnostic différentiel enfin c'est de la masse cervicale en général. Là, diagnostic différentiel d'une masse cervicale.

On peut apporter des choses mais en fait ce sont pas des masses cervicales, ce sont autres choses. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une masse cervicale. Par exemple je vais vous donner un exemple de la grande corne de la grande corne de la grande corne de la grande corne de quelqu'un de maigre cervicale et en fait c'est pas une masse c'est c'est juste la grande corne de l'océan.

D'accord? Qu'est-ce que ça en par rapport à d'autres? Très bien. C'est le tubercule de

chasseignac. Chasseignac Voilà donc pourquoi? Parce que c'est un français.

D'accord? Merci beaucoup. Alors on a la transference de l'atlas c'est les montagnes qui sont un c'est c'est un voilà tubercule de chasseignac chasseignac grande corne de l'océan un bulbe carotidien d'accord? En fait c'est c'est juste le la carotide qui a athéromateuse ça peut prêter à confusion et parfois on on a l'apthose de la grande corne de l'océan c'est juste la grande corne de l'océan d'accord? Suivons alors euh on a les diagnostics différents sur d'autres masses cervicales alors les masses latérales quand je parle d'une masse latérale est-ce que ça peut être? Alors ça peut être une tumeur vasculaire, une tumeur congénitale, une tumeur latérale, une tumeur congénitale, on a parlé tout à l'heure du catété mais dans le cas le cadre des tumeurs latérales ça ça peut être un d'accord? Les tumeurs vasculaires qu'est-ce qu'on peut avoir? Les tumeurs vasculaires? Alors nous on a parlé tout à l'heure. J'ai pas parlé du type histologique, c'est un paraganglion, un paraganglion, une tumeur nerveuse, ça peut être quoi? Très bien, bien, oui, très bien, ça fait l'intérieur.

Merci beaucoup. Alors un peu de silence. Alors une tumeur souvent du ça peut être une tumeur de la glande cible mandibulaire, d'accord? Sous-mental, inquisiteur thermoïde, inquisiteur du tractus stéréoglos.

Vous allez voir qu'en fait on va un peu parler de toutes les masses cervicales. Alors les autres masses cervicales, par exemple, les cancers, enfin les tumeurs prélarangés, prélarangés, ça peut être quoi? Tumeur prélarangé devant le larynx, ça peut être un catété, comme a dit votre ami tout à l'heure, ou bien parfois un cancer du larynx. De toute façon, généralement, les tumeurs médianes, généralement, ce ne sont pas des adénopathies.

Généralement, ce sont soit des catétés, soit un nodule thyroïdien, d'accord? La région cisclaviculaire, il faut faire attention, ça peut être une adénopathie satellite, mais ça peut aussi être un cancer de l'apex pulmonaire. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, en cas de suspicion, à demander un scanner, d'accord? Un scanner qui va faire la part des choses. Les tumeurs spinales, on peut avoir des tumeurs nerveuses ou bien des tumeurs parotidiennes.

Je me rappelle d'un patient qui avait, en fait, le radiologue qui parlait d'une adénopathie, on a fait l'ablation, à l'histologie, c'était une tumeur parotidienne, d'accord? On a été obligés de reprendre la patiente. Et on a, dans toutes les régions cervicales, on a les lipomes et les angions. Les angions, on en a parlé tout à l'heure, il y a les lipomes, c'est des tumeurs c'est des tumeurs dressées, d'accord? Euh, voilà, les lipomes.

Alors, on reprend les questions, on les répond comme ça ou bien on fait encore le concours? Peut-être que qu'il y aura un autre canine, non? De le concours ou là? D'accord? Yalla, allez-y, allez-y. À vos téléphones, à vos téléphones, vite, vite, Yalla, on va faire très vite. Simba, qui est Simba? Yalla, vite, vite.

Alors, devant une adénopathie cervicale, lequel de ses examens par clinique est à demander en

premier? T3, T4, TSH, échographie j'imagine que tout le monde a répondu voilà échographie cervicale alors alors alors on fait la deuxième deuxième question c'est disponible à évoquer en premier alors ça peut être autre chose concert du c'est voilà c'est très bien oui alors troisième question quarante-cinq ans minuisie trois mois à l'hypothèse cervicale avec la réponse concernant j'ai comment d'accord c'est je suis oui le concert du minuisie c'est vrai ça se passe ici c'est proposé c'est dans alors question quatre adolescents premier on verra bien tuberculose s'il vous plaît je veux discuter avec ce monsieur ou la concerte aïe aïe aïe aïe bien sûr c'est bien sûr c'est la rapidité hein oui en temps c'est radio radio on ne la demande pas systématiquement c'est vrai d'accord alors on a notre gagnant bien sûr c'est c'est je pense voilà merci beaucoup la conclusion alors alors alors examen un bilan systématique qui comporte quoi le bilan systématique ça peut être un scanner ça peut être un ça peut être d'accord en fonction du contexte exploratrice avec constitue parfois le dernier la dernière exploration et le premier geste thérapeutique je vous remercie merci oui ah dans ce cas on fait un servicotomie exploratrice on enlève